철결핍성 빈혈,
원인을 찾고 채워주면 회복됩니다

원인 · 진단 · 철분제 · 식사 · 재발 방지

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

가장 흔한 빈혈 — 한국 가임기 여성 약 10명 중 1명

전 세계 빈혈의 약 절반이 철결핍성입니다. 남성·폐경 뒤 여성은 출혈 원인을 꼭 찾습니다

11.5%

한국 가임기 여성(15~49세)의 철결핍성 빈혈

생리 출혈·임신·식사 부족이 쌓여 생깁니다

? 빈혈은 '결과'입니다

빈혈 자체가 진단이 아니라, 무언가가 철을 빼앗고 있다는 신호입니다.

원인을 꼭 찾습니다

남성·폐경 뒤 여성·어르신의 철결핍성 빈혈은 약 10%에서 위암·대장암 같은 소화관 출혈이 원인입니다.

철분제만 먹지 마세요

철분을 채우는 것과 함께 출혈 원인을 찾습니다 — 위·대장 내시경을 권합니다.

Tip · 피곤함이 오래가면 혈액검사로 확인하세요 — 원인 평가는 그다음 단계입니다.

근거 · 국민건강영양조사 2010(Lee 등, 대한의학회지 2014) · 대한혈액학회 철결핍성 빈혈 지침 2022 · 세계보건기구 빈혈 추정 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

철결핍성 빈혈이란 — 철이 모자라 산소를 덜 나르는 상태

철은 헤모글로빈(산소를 나르는 단백질)의 중심입니다 — 모자라면 작고 창백한 적혈구가 만들어집니다

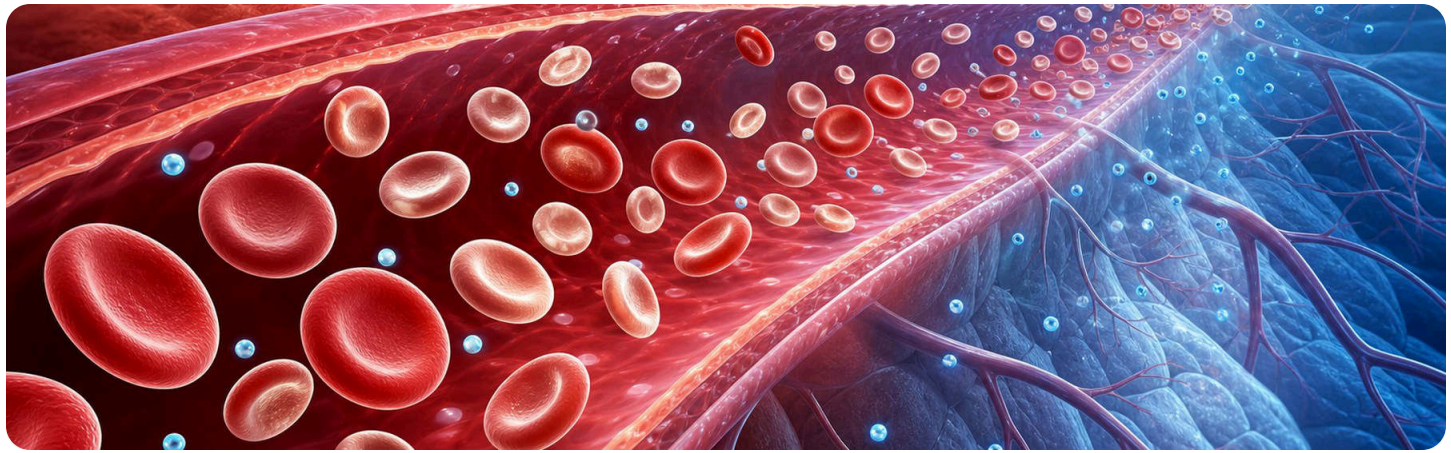


그림 · 철이 모자라면 적혈구가 작고 창백해져 산소를 덜 나릅니다(설명용 그림).

줄어드는 순서 ① 저장철(페리틴) → ② 운반철 → ③ 적혈구 크기 → ④ 마지막에 헤모글로빈

가장 예민한 지표 · 페리틴

30 미만은 철결핍을 시사합니다. 만성질환이 섞이면 100~200도 가능합니다. 헤모글로빈이 정상이어도 페리틴만 낮으면 진단·치료합니다.

적혈구 모양

적혈구 크기(MCV)가 작아지고 크기가 들쭉날쭉(RDW 상승)해집니다.

Tip · 페리틴은 '몸에 저장된 철'을 보여주는 혈액검사 수치입니다.

근거 · 대한혈액학회 철결핍성 빈혈 지침 2022 · 영국혈액학회 지침 2021 · 아산 28회 연수강좌 — Hemoglobin(혈색소) 이상에 대한 접근(최은지)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

왜 철이 부족해지나 — 흔한 원인 여섯 가지

'잃는 양이 흡수보다 많거나', '필요한 양이 공급보다 많을 때' — 진단 뒤 반드시 원인을 봅니다



♀ 월경과다

가장 흔한 원인. 패드·탐폰을 자주 갈거나 큰 핏덩어리가 나오면 부인과 진료를 권합니다.

위·대장 출혈

남성·폐경 뒤 여성·어르신에서 먼저 의심합니다. 궤양·위암·대장암·치질 — 내시경이 필요합니다.

식사 부족·채식

붉은 고기 섭취 부족, 채식 위주, 어르신 식사량 감소, 우유만 먹는 아이.

흡수 장애

위 절제술·헬리코박터·셀리악병·위산 억제제 장기 복용 — 철은 십이지장에서 흡수됩니다.

임신·수유·성장기

임신 중 철 필요량이 약 3배로 늘어 정기 산전 검사가 필요합니다.

⚠ 숨은 출혈 — 암 가능

증상 없이 자라는 위장관·콩팥 종양. 남성·폐경 뒤 여성은 출혈을 평가합니다.

Tip · 원인을 찾지 않고 철분만 채우면 빈혈이 되풀이될 수 있습니다.

근거 · 대한혈액학회 철결핍성 빈혈 지침 2022 · 영국혈액학회 지침 2021 · 미국소화기학회 2020 · 아산 28회 연수강좌 — Hemoglobin(혈색소) 이상에 대한 접근(최은지)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

천천히 진행해서 본인은 잘 모릅니다

몸이 적응해 증상이 약합니다 — 적은 활동에도 평소보다 힘들면 의심하세요

피로 · 무기력

가장 흔합니다. 푹 자도 피곤하고 평소 하던 일이 버겁습니다.

움직일 때 숨참

계단·빠른 걷기·집안일에서 평소보다 숨이 찹니다 — 산소 운반이 떨어진 신호.

어지러움 · 두통

일어설 때 눈앞이 캄캄하고 두통이 잦습니다. 심하면 쓰러질 수 있습니다.

손톱 · 머리카락

손톱이 잘 부서지고 숟가락처럼 오목해지며, 머리카락이 많이 빠집니다.

얼음 깨물기 · 이식증

얼음·흙·종이·녹말 같은 음식 아닌 것이 당깁니다 — 철결핍의 특징적 증상.

다리 불편 · 두근거림

하지불안 증상이 심해지고, 가만히 있어도 가슴이 두근거립니다(심한 빈혈).

Tip · 증상이 가벼워도 수치는 많이 떨어져 있을 수 있습니다.

근거 · 대한혈액학회 철결핍성 빈혈 지침 2022 · 뉴잉글랜드 의학저널 철결핍 종설 2015

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진단 — 네 가지 수치를 함께 봅니다

헤모글로빈 하나로는 부족합니다 — 페리틴과 철 포화도를 꼭 함께 봅니다

검사	기준	뜻
헤모글로빈	남 13.0 · 여 12.0 g/dL 미만	빈혈. 정상이어도 페리틴이 낮으면 철결핍으로 치료합니다.
적혈구 크기 (MCV)	80 fL 미만	작은 적혈구 — 철결핍의 전형이지만 초기엔 정상일 수 있습니다.
페리틴 — 가장 예민	**30 ng/mL 미만**	저장철이 바닥 — 철결핍이 거의 확실합니다. 만성질환이 동반되면 100~200에서도 철결핍이 섞일 수 있습니다.
철 포화도 (TSAT)	16% 미만	피 속 운반철이 모자람. 페리틴이 정상인데 염증이 의심될 때 보조로 봅니다.

Tip · 결과지의 Hb는 헤모글로빈, Ferritin은 페리틴입니다.

근거 · 대한혈액학회 철결핍성 빈혈 지침 2022 · 영국혈액학회 지침 2021 · 세계보건기구 빈혈 진단 기준 · 아산 28회 연수강좌 — Hemoglobin(혈색소) 이상에 대한 접근(최은지)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

철 검사와 과거력으로 원인을 좁힙니다

작은 적혈구가 모두 철결핍은 아닙니다.

검사를 함께 읽기

- 철결핍의 전형은 iron 감소·TIBC 증가·ferritin 감소입니다. CBC·망상적혈구·말초혈액도말도 함께 봅니다.
- 만성콩팥병·류마티스관절염 등에서는 만성질환빈혈과 철결핍이 함께 올 수 있습니다.
- 최은지 연자는 애매한 혼합 상황에서 경구 철분 1~2개월 뒤 혈색소 반응을 살펴본다고 설명했습니다.

vs

숨은 단서를 말하기

- MCV가 작아도 저장철이 낮지 않으면 지중해빈혈 등 다른 원인도 고려합니다.
- 어릴 때부터의 빈혈·가족의 빈혈·이전 검사 결과가 단서가 됩니다.
- 치질 출혈·사혈·피를 빼는 부항·잦은 헌혈도 진료 때 알려주세요.

아산 28회 연수강좌 — Hemoglobin(혈색소) 이상에 대한 접근(최은지)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

먹는 철분제 — 흡수를 높이는 방법까지

대부분 먹는 철분제로 회복합니다. 이틀에 한 번 먹는 편이 흡수가 더 좋을 수 있습니다

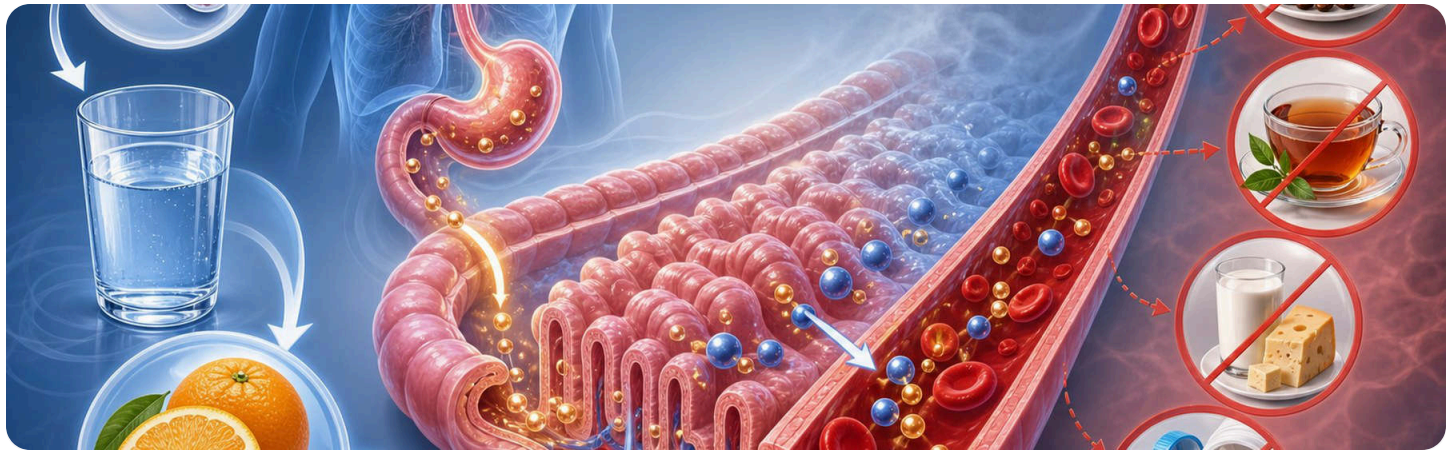


그림 · 공복에 먹는 것이 가장 좋고, 차·우유·칼슘제와는 시간을 띄웁니다(설명용 그림).

먹는 법 하루 1번, 공복(식사 1시간 전)이 흡수가 가장 좋습니다. 속이 불편하면 식사 직후도 괜찮고, 부작용이 심하면 격일로 먹습니다.

2~8주

헤모글로빈 회복

4주 뒤 재검으로 반응을 확인합니다

3개월 더

저장철 채우기

헤모글로빈이 정상이 된 뒤에도 약 3개월 더 — 끝낼 때는 혈액검사로 정합니다

Tip · 검은 변은 철분제 때문에 흔히 생깁니다 — 붉은 피가 섞이면 바로 알려 주세요.

근거 · 대한혈액학회 철결핍성 빈혈 지침 2022 · 영국소화기학회 철결핍성 빈혈 지침 2021 · Stoffel 등, 란셋 혈액학 2017 (격일 복용)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

먹는 약으로 부족할 때 — 정맥 철분 주사와 원인 찾기

위장 부작용·흡수 장애·심한 빈혈·임신 후기에는 정맥 주사가 빠른 회복을 돕습니다

정맥 철분 주사

먹는 약을 못 견디거나 흡수가 안 될 때, 심한 결핍·임신 28주 이후·만성 콩팥병에서 씁니다. 드물게 심한 알레르기 반응이 생길 수 있습니다.

출혈 원인 찾기

남성·폐경 뒤 여성은 위·대장 출혈을 평가합니다. 원인 불명의 철결핍이 반복되면 캡슐내시경 등 추가 검사를 고려합니다.

부작용 줄이기

변비·메스꺼움 → 이틀에 한 번·적은 양부터·식사 직후, 식이섬유와 물. 검은 변은 정상입니다.

수혈은 언제

증상이 있으면서 헤모글로빈 7~8 미만이거나 혈압이 불안정할 때. 급하지 않은 철결핍에서 수혈은 첫 선택이 아닙니다.

Tip · 주사도 원인을 고치지는 못합니다 — 출혈 원인 찾기가 함께 가야 합니다.

근거 · 대한혈액학회 철결핍성 빈혈 지침 2022 · 영국혈액학회 지침 2021 · 세계보건기구 수혈 기준 · 아산 28회 연수강좌 — Hemoglobin(혈색소) 이상에 대한 접근(최은지)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

철 흡수를 돕는 식사 vs 막는 식사

철분제와 함께 먹으면 흡수를 높이는 음식과, 떨어뜨리는 음식을 시간을 나눠 배치합니다

흡수를 돕는 음식

음식 속 철의 흡수를 돕습니다

- 비타민 C — 오렌지·키위·딸기·피망·브로콜리
- 붉은 고기·간 — 흡수가 잘 되는 헴철(흡수율 25%)
- 달걀·생선·닭고기, 철분 강화 시리얼
- 시금치·근대·콩·두부 — 비타민 C와 함께

vs

흡수를 막는 음식

철분제와 2시간 이상 떨어뜨리기

- 차·커피 — 탄닌이 흡수를 50~80% 줄입니다
- 우유·요거트·치즈·칼슘제 — 칼슘이 경쟁합니다
- 제산제·위장약, 통곡물·견과 다량, 적포도주 과량
- 갑상선약은 철분제와 시간을 나눠 먹습니다

Tip · 커피·차는 철분제와 두 시간 띄우세요 — 식품별 철분 함량·식단은 식사 안내문을 드립니다.

근거 · 대한혈액학회 철결핍성 빈혈 지침 2022 영양 부록 · Hallberg 철 흡수 종설

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

바로 확인이 필요한 신호 — 단순 빈혈로 넘기지 마세요

아래 상황은 출혈·암 가능성을 확인해야 하며, 철분제만으로 끝내면 안 됩니다

남성 · 폐경 뒤 여성의 빈혈

생리가 없는데 철결핍이 생기면 위·대장 출혈을 먼저 의심합니다 — 내시경 필수.

검은 변 · 피 섞인 변 · 피 토함

짜장 같은 검은 변(위·소장), 붉은 변(대장) — 바로 내원하세요.

체중 감소·식욕 저하·복통

소화관·림프계 암 가능성 — CT나 내시경을 먼저 합니다.

4주 먹어도 반응 없음

헤모글로빈이 1 이상 안 오르면 진단·흡수·계속되는 출혈을 다시 봅니다.

갑자기 숨참 · 가슴 통증

심한 빈혈에서 심장이 버거울 수 있습니다. 헤모글로빈 7~8 미만 + 증상이면 응급실.

임신 중 헤모글로빈 9 미만

조산·저체중아 위험 — 산과 협진과 정맥 주사를 고려합니다.



Tip · 검은 변이 철분제 때문인지 출혈 때문인지 헷갈리면 먼저 연락하세요.

근거 · 대한혈액학회 철결핍성 빈혈 지침 2022 · 영국혈액학회 지침 2021 · 미국소화기학회 2020

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

회복과 재발을 혈색소·저장철로 함께 봅니다

최은지 연자 Q&A · 내시경 이후에도 반복 빈혈은 다시 평가합니다.

반복되는 빈혈

- 최은지 연자는 Q&A에서 위장관 출혈을 배제하고 생리과다 등 원인이 명확하면 ferritin 회복까지 치료한다고 답했습니다.
- 원인 불명의 철결핍이 반복되면 잠재 위장관 출혈과 상급병원 평가를 고려한다고 답했습니다.
- 헬리코박터·혈뇨 검사·복부 CT 등은 모두에게 일괄 시행하지 않고 필요에 따라 선택합니다.

vs

치료 반응과 저장철

- 최은지 연자는 Q&A에서 약 1개월 뒤 CBC·망상적혈구·ferritin과 복용 상태를 확인한다고 답했습니다.
- 혈색소 정상화 뒤에도 2~3개월 추가 복용해 저장철까지 회복시키는 것이 목표라고 답했습니다.
- 주사 철분은 심한 불내성·지속 출혈·위전절제나 활동성 장염에 따른 흡수장애에서 고려합니다.

아산 28회 연수강좌 — Hemoglobin(혈색소) 이상에 대한 접근(최은지)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

월경량과 불규칙 출혈도 원인 평가에 중요합니다

빈혈 치료와 함께 여성의 출혈 양상을 확인합니다.

월경 기록

- 생리대를 자주 바꾸거나 밤마다 큰 패드를 쓰는지, 최근 3~6개월의 주기·기간·양을 기록합니다.
- 오랫동안 월경량이 많았던 분은 스스로 많다고 느끼지 못할 수 있습니다.
- 초경 때부터 심한 월경과다가 있으면 출혈장애 평가도 고려합니다.

vs

산부인과 평가가 필요한 때

- 폐경 후 출혈은 소량·일시적이어도 산부인과 평가를 받습니다.
- 성교 후 출혈도 자궁경부 병변 여부를 확인합니다.
- 심한 어지러움·실신 등 빈혈 증상이 있으면 진료를 미루지 않습니다.

아산 28회 연수강좌 — 월경이 불규칙한 환자, 무엇을 확인해야 하나?(이사라)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

복용·식사·추적 — 일곱 가지만 기억하세요

제대로 먹고 추적하면 대부분 회복하고 재발도 줄일 수 있습니다

01 철분제는 공복(식사 1시간 전), 속이 불편하면 식사 직후

02 차·우유·칼슘은 철분제와 2시간 이상 띄우기

03 매일 또는 이틀에 한 번 — 처방대로, 속이 불편하면 격일로

04 검은 변은 정상, 피 섞인 변은 바로 내원

05 1개월 뒤 헤모글로빈 재검 — 1 이상 올랐는지 확인

06 정상이 된 뒤에도 약 3개월 더 — 끝낼 때는 혈액검사로

07 다시 생기면 생리·소화관·약·식사 원인을 다시 점검

Tip · 붉은 고기·간은 주 2~3회, 또는 콩·두부에 비타민 C를 곁들이세요.

근거 · 대한혈액학회 철결핍성 빈혈 지침 2022 · 영국혈액학회 지침 2021

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

원인을 찾고 꾸준히 채우면 회복을 기대할 수 있습니다

빈혈은 결과이지 진단이 아닙니다 · 복용법은 철분제 안내문, 식단은 식사 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

철결핍성 빈혈 진단을 받았거나 철분제를 처방받은 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 원인 검사와 치료 기간은 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

대한혈액학회 철결핍성 빈혈 지침 2022 · 영국혈액학회 지침 2021 · 미국소화기학회 철결핍 합의 2020 · Stoffel 란셋 혈액학 2017 · 세계보건기구 빈혈 자료

다시 보기 · 카톡 공유